

F5 인계 요약 보고서 — VP-001

핵심 요약

- 환자: 김서연 (VP-001) — 11회차 (2027-01-14), 총 11세션 · 183일
- 주호소: 잠들기 힘들고 새벽에 자주 깨는 증상
- 위험 플래그: 자살사고 문항 양성 이력 없음 (자가보고 기준)
- 최신 설문: PHQ-9 17/27 (중등도-중증) ↓ (19→17, 1회차 대비)
- 주요 우려: 특이 우려 사항 없음

면책 조항

- 자가보고(AI 대화형 문진) 기반 비공식 문서이며 공식 의무기록·의학적 진단이 아닙니다.
- AI 예상질환(하단)은 유사도 기반 참고 정보일 뿐 확률·가능성·진단이 아닙니다.
- 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

위험/안전 평가

당해 세션(11회차, 2027-01-14) 위험평가: 자살/자해 사고 탐색 질문에 대한 환자 응답: "회사에서 대규모 프로젝트를 진행하면서부터 잠들기 전부터 마음이 조마조마해졌어요. 퇴근 후에도 어깨와 목이 뻣근하고, 가끔 가슴이 답… (상세 부록 1 참조). 위기 단계(CTRS) 4/5 — 경도 우려 (준안정).

해당 없음 — item-9 양성/안전 의뢰 이력 없음

최신 시행 척도 안내: 당해 세션에 F3 문진이 시행되어 별도 최신성 안내가 필요하지 않습니다.

주호소 및 현병력

주호소: 잠들기 힘들고 새벽에 자주 깨는 증상

현병력: 지난번에 비하면 조금 나아진 것 같아요. 작은 마감은 있었지만 예전처럼 정신없이 흔들리진 않았고, 잠도 여전히 잘 안 오긴 했지만 새벽에 더 자주 깨는 건 좀 줄어든 느낌이에요. 전반적으로는 마음이 덜 답답하고, 회사에서도 실수는 가끔 있지만 지적받는 빈도는 좀 줄어든 것 같아요.

정신상태검사 (MSE)

텍스트 문진 특성상 관찰 기반 MSE는 평가 불가; 대화에서 도출된 소견 없음

전체 세션 요약

이 표의 값은 AI가 진행한 대화형 문진(F1)에서 환자가 자가보고한 내용이며, 임상과의 직접 평가나 검증된 척도 시행이 아닙니다.

슬롯	최신값
주호소	잠들기 힘들고 새벽에 자주 깨는 증상
현병력	지난번에 비하면 조금 나아진 것 같아요. 작은 마감은 있었지만 예전처럼 정신없이 흔들리진 않았고, 잠도 여전히 잘 안 오긴 했지만 새벽에 더 자… (상세 부록 2 참조)
정신과 과거력	미수집
신체질환/신경학적 병력	미수집
개인사/사회력	퇴근 후 무기력해져 운동도 거의 하지 않고 저녁도 가볍게만 먹거나 건너뛰는 날이 생김
가족력	어머니의 수면 문제와 스트레스 시 신체 뻣뻣함
음주·흡연·물질사용	커피 대신 차 위주로 마심
위험평가	자살/자해 사고 탐색 질문에 대한 환자 응답: "회사에서 대규모 프로젝트를 진행하면서부터 잠들기 전부터 마음이 조마조마해졌어요. 퇴근 후에도 어… (상세 부록 3 참조)

주요 경과

- 주호소: S1: '잠 못 자는 문제로 인해 낮에도 집중이 어렵고 실수가 늘어나 속상함' → S6: '가슴 답답함과 어깨 뻣근함이 아침에 덜함' → S10: '잠들기 힘들고 새벽에 자주 깨는 증상'

- 현병력: S1: '회사에서 대규모 프로젝트 진행 시작 후 잠들기 전부터 마음이 조마조마해지고, 새벽 2-3회 깨며 아침에 개운...' → S7: '지난번 불면과 가슴 답답함이 개선되었으나, 최근 피로로 인해 집중이 잘 안 되는 증상이 재발' → S11: '지난번에 비하면 조금 나아진 것 같아요. 작은 마감은 있었지만 예전처럼 정신없이 흔들리진 않았고, 잠도 여전...'
- 개인사/사회력: S2: '회사 동료와 주 2회 통화, 퇴근 후 혼자 있는 시간 증가, 최근 연락 감소' → S9: '퇴근 후 무기력해져 운동도 거의 하지 않고 저녁도 가볍게만 먹거나 건너뛰는 날이 생김'
- 가족력: S1: '어머니는 가끔 잠 못 주무심' → S10: '어머니의 수면 문제' → S11: '어머니의 수면 문제와 스트레스 시 신체 뻣뻣함'

시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

PHQ-9 17/27 (중등도-중증) — 11회차 (2027-01-14)

응답: 2,1,3,2,2,2,3,2,0

자살사고 문항(9번): 음성 | 문진 방식: natural

종단 추세 — 전체 방향: 개선

전체 방향은 척도·위기단계·정서 방향의 다수결로 계산되며, 악화 신호가 하나라도 있으면 악화로 우선 판정합니다. 정서 포함 여부에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

항목	방향	근거
PHQ-9 총점	개선	PHQ-9: 세션 1→11: 19 → 17 (-2)
위기 단계(CTRS)	개선	세션 1→11: 3 → 4 (+1)
감성 점수	개선	세션 1→11: -0.540909 → -0.190909 (+0.35)
문진 항목 충족도	개선	세션 1→11: 5 → 6 (+1)

- 위기 반응 발생 세션 없음
- 위험 고조 세션 중 설문 미시행 사례 없음
- 종단 추세 일관성(설문·CTRS·감성): 일치

추세 차트

VP-001_20260715_161415_temporal_scales_ctrs_sentiment.png

F4 종단 추이 — VP-001 VP-001

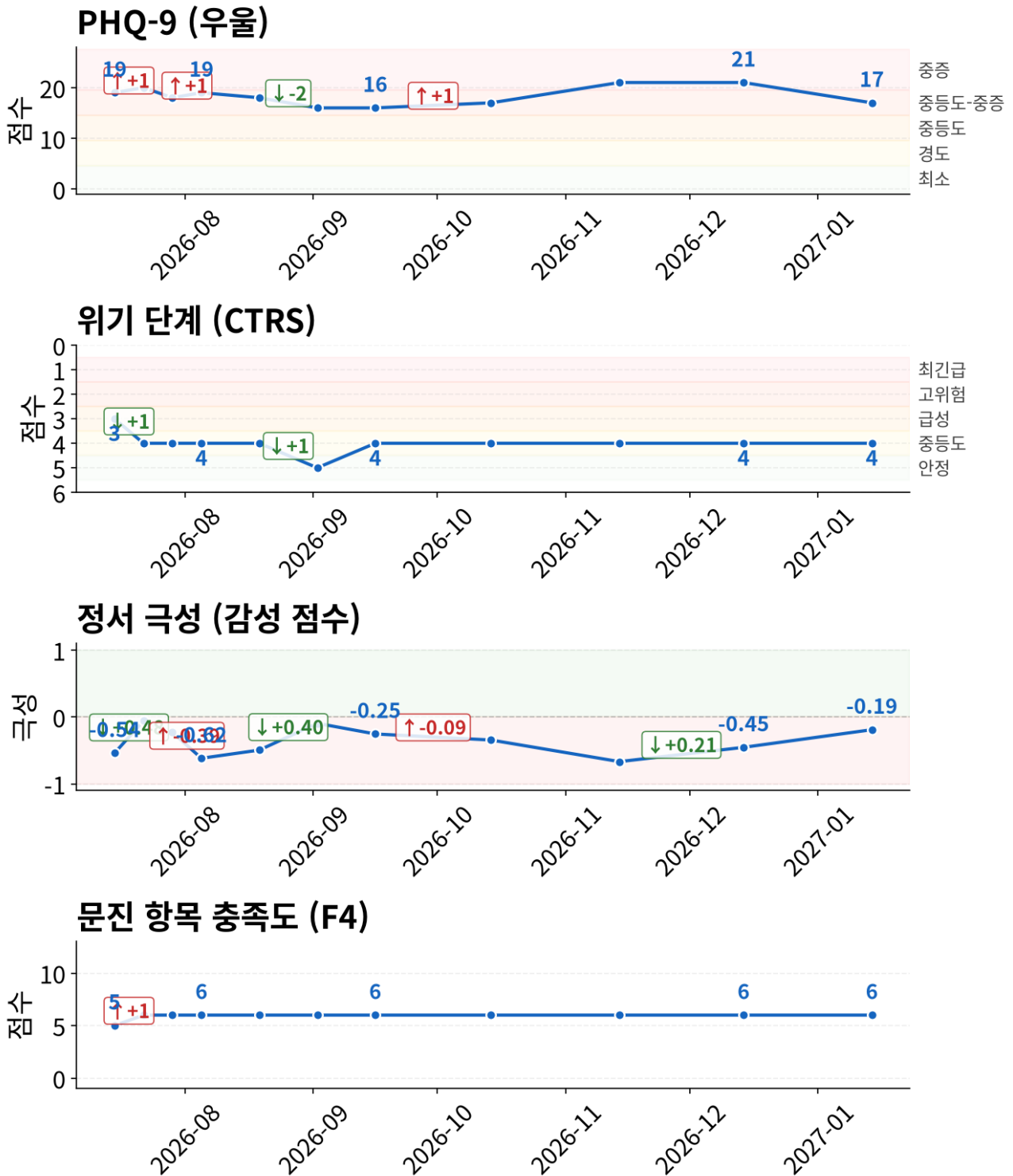


그림 1. 설문 총점·위기 단계(CTRS)·정서·문진 충족도 추이 (11세션, 183일) — 위기 단계는 값이 낮을수록(1에 가까울수록) 위험이 높습니다.

VP-001_20260715_161415_temporal_ctrs_zoom.png

F4 위기단계(CTRS) 확대 — VP-001

VP-001

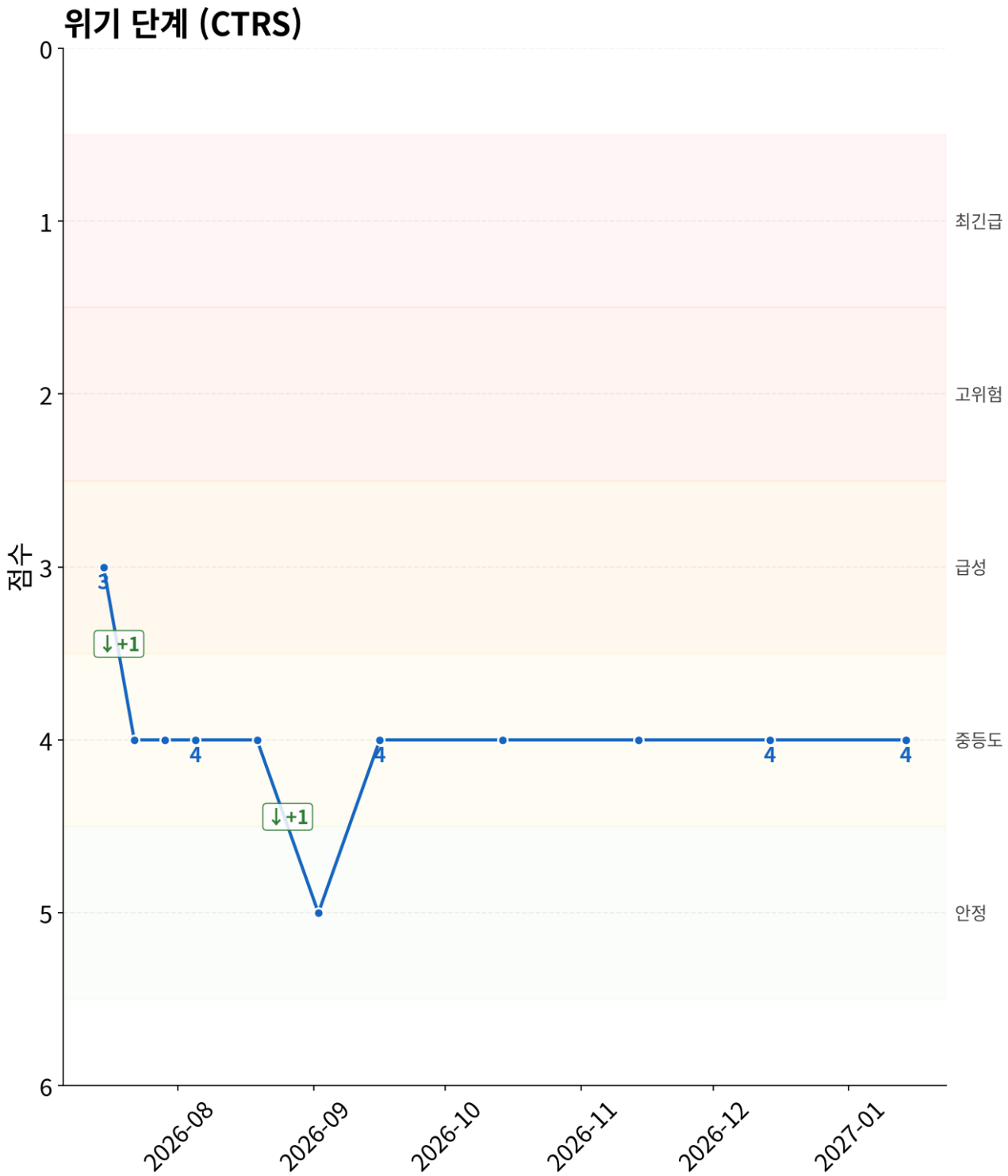
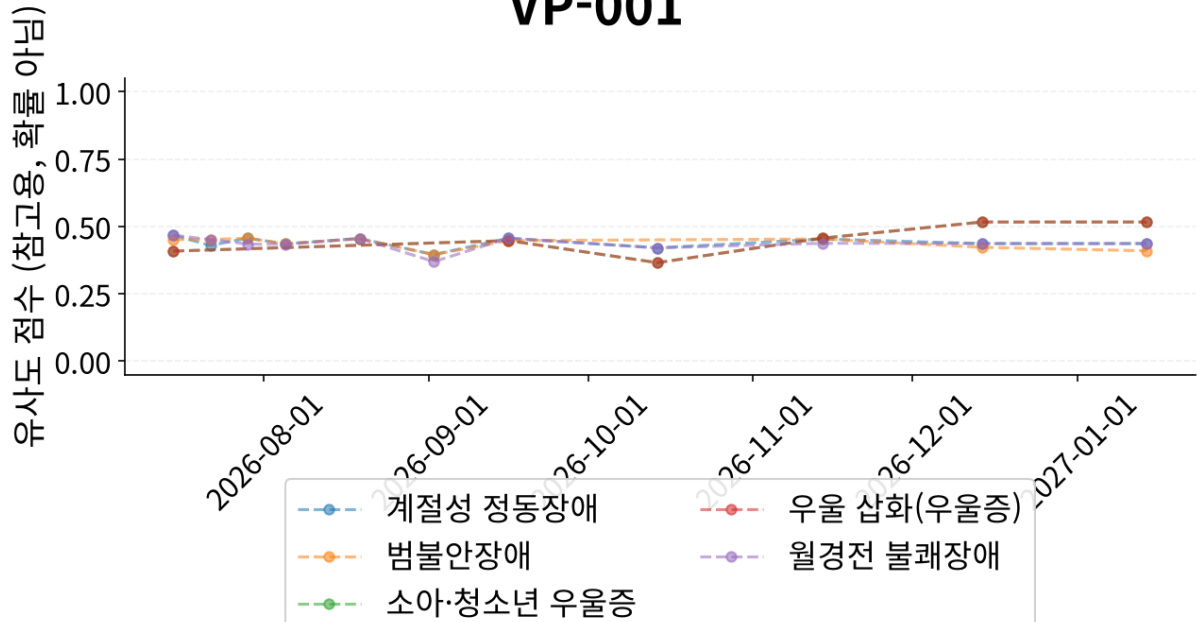


그림 2. 위기 단계(CTRS) 확대 추이 — 1(최긴급)에 가까울수록 위험, 5(안정)에 가까울수록 안정적입니다.

VP-001_20260715_161415_temporal_disease_similarity.png

질환 유사도 추이 (F4, 질환별) VP-001

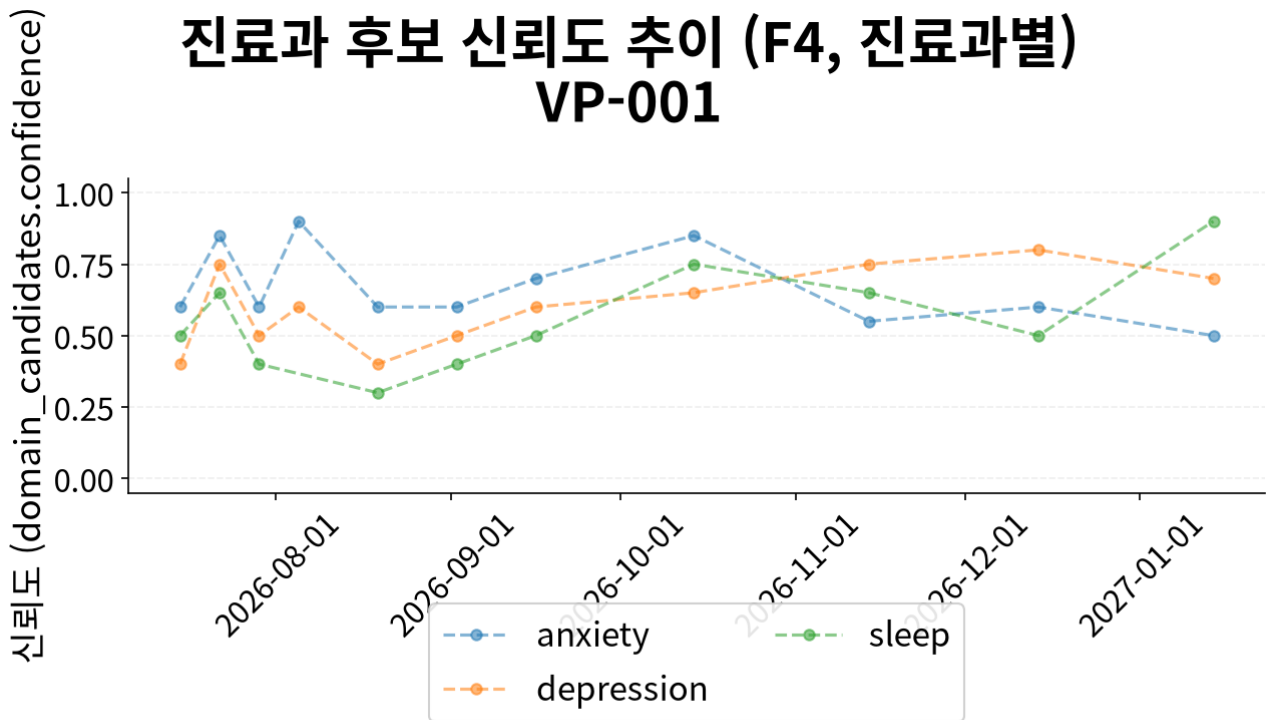


점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호. VAL-014(마해결): F2 질환 후보 산출의 타당성이 아직 검증되지 않았습니다 — 이 추이는 노이즈가 포함된 입력을 기반으로 계산되며, 임상적 추이 해석 용도로 사용할 수 없습니다.

그림 3. 세션별 질환 유사도 추이 — 점선·저채도 선은 참고용 유사도 신호일 뿐이며 확률·가능성·진단이 아닙니다.

VP-001_20260715_161415_temporal_domain_confidence.png

진료과 후보 신뢰도 추이 (F4, 진료과별) VP-001



점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호.

그림 4. 세션별 진료과 후보 신뢰도 추이 — 값이 높을수록 해당 진료과 매칭 신뢰도가 높습니다.

AI 참고 정보 (비진단)

⚠ 유사도(similarity)일 뿐 확률·가능성·신뢰도가 아닙니다 — 임상 판단 대체 불가.

순위	질환	유사도
공동 1위	우울 삽화(우울증)	0.516
공동 1위	소아·청소년 우울증	0.516
공동 3위	계절성 정동장애	0.436

기타 후보: 월경전 불쾌장애(0.436), 범불안장애(0.409)

disclaimer: 이 정보는 AI가 생성한 참고용 예상 질환 후보이며 의학적 진단이 아닙니다. 함께 제공되는 설문 추천(recommended_questionnaire) 역시 초기 상담(인테이크) 지원을 위한 척도 제안일 뿐, 진단적 판단이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

권장 진료과 및 후속 조치

진료과	사유
정신건강의학과	수면 장애, 우울감, 불안 증상이 복합적으로 나타나며, PHQ-9 21점(중증)으로 우울 증상이 확인됨. 수면 패턴 변화, 흥미 감소, 자존감 저하, 집중력 저하 등.
정신건강의학과	수면 문제와 함께 우울감, 무기력함, 자존감 저하 등의 증상이 보고됨. PHQ-9 21점(중증)으로 우울 증상이 확인됨.
정신건강의학과	불안 증상, 정서조절 어려움, 실수에 대한 사후 반추 등이 보고됨. 수면 문제와 함께 불안 관련 증상이 관찰됨.

추천 설문: PHQ-9 — PHQ-9 screens depressive-symptom burden only, does not screen manic/hypomanic symptoms — bipolar-spectrum presentations need clinician follow-up regardless of score.

약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

임상 종합 소견

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

상세 부록

1. 위험평가 발화 원문 (당해 세션)

자살/자해 사고 탐색 질문에 대한 환자 응답: "회사에서 대규모 프로젝트를 진행하면서부터 잠들기 전부터 마음이 조마조마해졌어요. 퇴근 후에도 어깨와 목이 뻣근하고, 가끔 가슴이 답답한 느낌이 ..."

2. 현병력 최신값 전문

지난번에 비하면 조금 나아진 것 같아요. 작은 마음은 있었지만 예전처럼 정신없이 흔들리진 않았고, 잠도 여전히 잘 안 오긴 했지만 새벽에 더 자주 깨는 건 좀 줄어든 느낌이에요. 전반적으로는 마음이 덜 답답하고, 회사에서도 실수는 가끔 있지만 지적받는 빈도는 좀 줄어든 것 같아요.

3. 위험평가 최신값 전문

자살/자해 사고 탐색 질문에 대한 환자 응답: "회사에서 대규모 프로젝트를 진행하면서부터 잠들기 전부터 마음이 조마조마해졌어요. 퇴근 후에도 어깨와 목이 뻣근하고, 가끔 가슴이 답답한 느낌이 ..."

슬롯별 전체 변화 이력 (미압축)

주호소

S1: '잠 못 자는 문제로 인해 낮에도 집중이 어렵고 실수가 늘어나 속상함' → S2: '잠이 조금 나아졌으나 아침에 개운하지 않고 낮에 멍해지는 증상이 지속됨' → S3: '수면이 조금 나아지고 식욕도 서서히 돌아오고 있으나, 일 생각이 나면 가슴이 답답해지고 어깨가 뻣뻣해지는 증상이 지속됨' → S4: '가슴 답답함과 어깨 뻣뻣함이 여전히 가끔씩 느껴지며, 아침에 업무 메일을 확인할 때 가슴이 조이는 느낌이 있음' → S5: '가슴 답답함과 어깨 뻣뻣함이 아침에 더 자주 느껴지고, 퇴근 후 소파에 눕는 습관이 심해짐' → S6: '가슴 답답함과 어깨 뻣뻣함이 아침에 덜함' → S7: '불면이나 가슴 답답함은 나아졌으나, 최근 피로로 인해 집중이 잘 안 되는 날이 가끔 생김' → S8: '잠도 잘 못 자고 집중이 잘 안 되는 날이 가끔 있음' → S9: '잠이 잘 안 오고 아침에 피곤하게 깨며 집중이 잘 안 되는 증상' → S10: '잠들기 힘들고 새벽에 자주 깨는 증상'

현병력

S1: '회사에서 대규모 프로젝트 진행 시작 후 잠들기 전부터 마음이 조마조마해지고, 새벽 2-3회 깨며 아침에 개운하지 않음. 낮에 집중이 잘 안 되고 실수가 늘어나 속상함. 아침을 자주 거르고 식사량이 줄어 체력이 떨어지며 운동도 예전처럼 못함. 어깨와 목 뻣근함, 가끔 가슴 답답함 동반' → S3: '회사 대규모 프로젝트 진행 시작 후 잠들기 전부터 마음이 조마조마해지고 새벽 2-3회 깨며 아침에 개운하지 않음. 낮에 집중이 잘 안 되고 실수가 늘어나 속상함. 아침을 자주 거르고 식사량이 줄어 체력이 떨어지며 운동도 예전처럼 못함. 어깨와 목 뻣근함, 가끔 가슴 답답함 동반. 2주 만에 요가 수업에 다녀와 기분 전환되었으나, 일 생각이 나면 다시 긴장됨. 깊은 숨을 쉬려고 노력하지만 금방 가라앉지 않고, 집에 와서 차 한 잔 마시며 잠깐 멈추는 것이 도움이 되나 퇴근 후 소파에 눕는 것이 편해 자주 못함' → S4: '아침 업무 메일 확인 시 가슴이 조이는 느낌이 재발하며, 스트레스 상황에서 조마조마함과 함께 나타남. 과거보다 덜하지만 긴장되는 일이 있을 때 다시 증상이 나타남. 요가 수업으로 기분 전환되었으나 일 생각이 나면 다시 긴장됨. 깊은 숨을 쉬려고 노력하지만 금방 가라앉지 않고, 집에 와서 차 한 잔 마시며 잠깐 멈추는 것이 도움이 되나 퇴근 후 소파에 눕는 것이 편해 자주 못함' → S5: '가슴 답답함과 어깨 뻣뻣함이 아침에 더 자주 느껴지며, 퇴근 후 소파에 눕는 습관이 심해짐. 피로가 남아 있고, 새 프로젝트 시작으로 긴장되는 느낌과 조마조마한 기분이 가끔 났음. 요가 수업으로 기분 전환되나 일 생각이 나면 다시 긴장됨. 깊은 숨을 쉬려고 노력하지만 금방 가라앉지 않고, 집에 와서 차 한 잔 마시며 잠깐 멈추는 것이 도움이 되나 퇴근 후 소파에 눕는 것이 편해 자주 못함' → S6: '가슴 답답함과 어깨 뻣뻣함이 아침에 덜하며, 퇴근 후 소파에 눕는 대신 10분 정도 걸으려고 노력함. 피로로 인해 금방 눕고 싶을 때가 있으나 스트레칭과 따뜻한 샤워로 관리함' → S7: '지난번 불면과 가슴 답답함이 개선되었으나, 최근 피로로 인해 집중이 잘 안 되는 증상이 재발' → S8: '지난 주말 친구와의 근교 방문으로 마음이 가벼워졌으나, 최근 다시 집중이 잘 안 되는 날이 가끔 발생함' → S9: '회사 프로젝트 마감으로 인한 스트레스가 쌓이면서 다시 잠들기 어려워지고 새벽에 자주 깨는 증상이 지속됨. 퇴근 후 무기력해져 운동도 거의 하지 않고 저녁도 가볍게 먹거나 건너뛰는 날이 생김. 기분이 가라앉는 날도 있으나 죽고 싶다는 생각은 없음. 업무 집중이 어려워 실수가 발생함' → S10: '프로젝트 종료 후 여유로워졌으나 잠들기 어려움과 새벽 각성 증상이 재발, 운동 부족으로 인한 신체 무거움 및 아침 기상 곤란, 가끔 가슴 답답함과 어깨 뻣뻣함 동반' → S11: '지난번에 비하면 조금 나아진 것 같아요. 작은 마음은 있었지만 예전처럼 정신없이 흔들리진 않았고, 잠도 여전히 잘 안 오긴 했지만 새벽에 더 자주 깨는 건 좀 줄어든 느낌이에요. 전반적으로는 마음이 덜 답답하고, 회사에서도 실수는 가끔 있지만 지적받는 빈도는 좀 줄어든 것 같아요.'

개인사/사회력

S2: '회사 동료와 주 2회 통화, 퇴근 후 혼자 있는 시간 증가, 최근 연락 감소' → S9: '퇴근 후 무기력해져 운동도 거의 하지 않고 저녁도 가볍게만 먹거나 건너뛰는 날이 생김'

가족력

S1: '어머니는 가끔 잠 못 주무심' → S10: '어머니의 수면 문제' → S11: '어머니의 수면 문제와 스트레스 시 신체 뻣뻣함'

설문 문항 출처: v1, verbatim Pfizer/phqscreeners.com Korean PHQ-9 PDF, retrieved 2026-07-13 (item_bank_v1_sources.md § 1.2/ § 1.3, appendix § A1); translation chosen per ADR-033 decision 1 (Seo & Park 2015's Korean validation study administered this same translation)

시스템 참고 (내부 감사용, 임상 판단 근거 아님)

종단 추세 판정 근거: overall_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로 계산되며(src.f4::_overall_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는 trend_verdicts의 evidence를 참고하십시오.